

心理危机干预与预防考试提纲开卷速查版

2026-04-21

打印速查目录

《心理危机干预与预防》开卷考试总提纲（压缩版）	2
一、先背这几个最高频核心定义	2
1. 心理危机的定义	2
2. 判断心理危机的三条标准	2
3. 危机干预的定义	2
4. 危机干预的两个主要目的	2
二、最容易考的大框架	2
1. 危机的两个含义	2
2. 危机的类型	2
3. 危机按进程分类	3
4. 危机后的四个阶段	3
5. 心理危机干预的分类	3
三、第二讲到第四讲：心理危机“为什么会发生”	3
1. 总模型：生物—心理—社会医学模式	3
2. 生物/生理因素	3
3. 心理因素	3
4. 社会/文化/现实因素	3
5. 两种危机来源模型	3
6. 成瘾行为背后的危机	3
四、依恋与创伤：很像论述题考点	3
1. 依恋的定义	3
2. 0~1岁的重要任务	3
3. 依恋创伤为什么重要	3
4. 依恋系统被激活后的矛盾	4
五、ASD、PTSD、自杀：这部分基本必考	4
1. 急性应激障碍 ASD	4
定义	4
常见应激事件	4
主要表现	4
2. PTSD	4
核心诊断思路	4
ASD 与 PTSD 的最简区别	4
3. 自杀部分：最容易出题的点	4
自杀不是单独疾病	4
自杀相关概念辨析	4
特殊概念	4
自杀先兆表现	4
高危线索	4
言语线索	5
行为线索	5
老师特别纠正的误区	5
六、危机干预怎么做：答题万能框架	5
1. 总原则	5
2. 法律伦理问题	5
保密原则不是绝对的	5
伦理重点	5
3. 危机干预三个阶段	5
4. 创伤/危机干预三阶段模型	5
5. 什么时候开始干预	5
6. 危机干预的基本技巧	5
7. 安全措施	5
8. 危机中的典型反应	6

认知反应	6
情绪反应	6
行为反应	6
七、第六讲：学生心理危机三级预防，这里特别像简答题	6
1. 三级预防定义	6
2. 社会层面防自杀共识	6
3. 七类学生高风险对象	6
4. 高发时间、年级、场所	6
5. 学校特色活动	6
内观认知疗法	6
森田疗法	6
八、胡鑫宇案例：案例题基本答法	6
1. 个人因素	6
2. 家庭因素	7
3. 学校/教师因素	7
4. 同伴因素	7
5. 本人应对因素	7
6. 引出的理论点	7
九、第七讲：最后这节容易考“理解题”	7
1. 心理问题的客观存在	7
2. 内在批评者	7
3. 心理问题的三个特点（老师自己的总结）	7
4. 老师的理解重点	7
5. 最后的人生建议类考点	7
十、考场上最好用的“万能论述模板”	7
模板一：分析某学生为何出现心理危机	7
模板二：写如何干预	7
模板三：写预防	7
十一、最后给你一个“纸质速查索引”	8
最该带在最前面的只有这 1 页	8
需要细翻时看哪份笔记	8

好，我直接给你压成一版可用于开卷考试的总提纲。我按“先能答题，再细翻正文”的思路整理：把故事、案例细节尽量压缩，只保留容易出题的概念、框架、分类、标准和论述题答法。考试要求是开卷、只能带纸质资料、不能带电子设备，这一点在你的笔记里老师也明确说了。

《心理危机干预与预防》开卷考试总提纲（压缩版）

一、先背这几个最高频核心定义

1. 心理危机的定义

心理危机：个体面临突然的或重大的生活困境，无法用既有方式解决，从而出现**心理失衡**的状态。最简答法可以写成：

重大事件出现后，原有应对方式失效，个体在情绪、认知、躯体、行为等方面出现严重反应，并且自己缓不过来。

2. 判断心理危机的三条标准

1. 有重大事件 / 生活事件
2. 有严重反应：情绪、认知、身体、行为反应
3. 原有应对方式无效，不能有效自我缓解

3. 危机干预的定义

危机干预：属于广义心理治疗，运用心理治疗手段帮助危机中的当事人处理迫在眉睫的问题、恢复心理平衡、安全度过危机并重新适应生活。最早由 Caplan 于 1954 年提出。

4. 危机干预的两个主要目的

1. 避免自伤或伤人
2. 恢复心理平衡与心理动力，让人重新运转起来。

二、最容易考的大框架

1. 危机的两个含义

一是突发事件本身；二是人遭遇事件后的紧张失衡状态。

2. 危机的类型

按刺激来源分三类：

1. **发展性危机**：成长阶段转换引起，常规、可预期
2. **境遇性危机**：外部突发事件引起，如地震、疾病、战争
3. **存在性危机**：围绕人生意义、责任、自由、独立等产生的冲突与焦虑。

3. 危机按进程分类

急性危机、慢性危机、混合性危机。

4. 危机后的四个阶段

1. **冲击期**：震惊、惊慌失措
2. **防御期**：否认、合理化等防御机制出现
3. **解决期**：开始找资源、解决问题
4. **成长期**：部分人会成长，但不是人人都会成长。

5. 心理危机干预的分类

预防性干预、治疗性干预、补救性干预。老师还提到目前很多干预仍偏补救，预防性干预不够。

三、第二讲到第四讲：心理危机“为什么会发生”

这一块特别适合考简答题 / 论述题。

1. 总模型：生物—心理—社会医学模式

心理危机不是单一原因造成，而是**生物/生理因素 + 心理因素 + 社会文化因素**共同作用。

2. 生物/生理因素

可写：

- 遗传、气质、敏感性、冲动性差异
- 光照与季节变化影响情绪
- **季节性情感障碍 SAD**：冬季情绪低落、嗜睡、爱吃碳水、体重增加，高纬度地区更常见。

3. 心理因素

高频点直接背：

- 完美主义，尤其是高自我批评
- 冲动性与情绪调节失调
- 反刍性思维
- 失调的认知图式：对自我、他人、世界的负性模板
- 问题解决能力不足
- 对自身解决问题缺乏信心。

4. 社会文化/现实因素

- 经济压力、学业压力、就业压力、人际冲突
- 家庭环境、成长环境
- 社会文化会影响人怎么理解灾难和恢复
- 人是“系统中的人”，不能只怪个体本身。

5. 两种危机来源模型

这个很适合老师出理解题：

- **巨石模型**：突如其来的重大灾难
- **鞋里沙子模型**：日常小压力长期积累、不断摩擦。

6. 成瘾行为背后的危机

老师的核心观点不是“成瘾本身”，而是：

酒精成瘾、手机成瘾等常常只是表面，背后可能掩盖情绪冲突、家庭矛盾和长期心理危机。单纯“戒行为”常常治标不治本。

四、依恋与创伤：很像论述题考点

1. 依恋的定义

依恋是出生后与**重要抚养者**建立起来的情感连接，是**安全感**和**基本信任**的基础。

2. 0~1岁的重要任务

建立**信任感**。如果照料及时、稳定，孩子更容易形成：

- 世界是安全的
- 我是可爱的
- 我是有能力的。

3. 依恋创伤为什么重要

很多危机不只是“眼前这件事”，而是旧的依恋创伤被激活了。比如失恋后极端崩溃，常常不只是因为分手本身，还因为唤醒了早年被拒绝、被抛弃体验。

4. 依恋系统被激活后的矛盾

创伤会让人**更渴求关系**，同时又可能**更不信任关系**。这就使人既想求助，又害怕靠近别人。

五、ASD、PTSD、自杀：这部分基本必考

1. 急性应激障碍 ASD

定义

强烈应激事件后，**数分钟到数小时内出现急性应激反应**，病程**3 天以上，不超过 1 个月**。最关键病程标准就是：

3 天以上，不超过 1 个月。

常见应激事件

交通事故、亲人死亡、袭击、强奸、虐待、自然灾害、战争、恐怖袭击、重大公共卫生事件等。

主要表现

- 意识范围狭窄、意识清晰度下降
- 闯入性再体验
- 精神运动性抑制或兴奋。

2. PTSD

核心诊断思路

- 必须有创伤暴露
- 侵入性症状
- 回避
- 认知和心境负性改变
- 警觉性和反应性改变
- **病程超过 1 个月**
- 社会功能受损
- 排除酒药或躯体因素。

ASD 与 PTSD 的最简区别

- **ASD：3 天~1 个月**
 - **PTSD：超过 1 个月。**
-

3. 自杀部分：最容易出题的点

自杀不是单独疾病

自杀不是精神病诊断系统中的单独疾病诊断，但会出现在许多精神障碍中，所以社会意义重大，单独讨论。

自杀相关概念辨析

1. **自杀意念**：有想死念头，但还没转化为行为
2. **自杀计划**：已想好时间、地点、方式
3. **自伤行为**：如割腕
4. **自杀未遂**：已实施但未死亡
5. **自杀企图**：就是自杀未遂的另一种说法
6. **自杀死亡**：最终死亡。

特殊概念

- **扩大性自杀**：先杀家人再自杀
- **间接自杀 / 曲线自杀**：通过杀人等方式借法律惩罚实现死亡目的。

自杀先兆表现

高危线索

- 最近自杀过
- 有明确计划
- 家庭中刚有人自杀
- 近期重大失落
- 对生活失去兴趣
- 无助、绝望
- 饮酒吸毒突然增多
- 生活习惯突变
- 把珍贵物品送人
- 经常谈到死亡。

言语线索

直接：

- “我不想活了”
- “我想自杀”

间接：

- “没人能帮我”
- “没有我大家会更好”
- “生活没意义”
- “我受不了了”。

行为线索

- 严重抑郁
- 行为突然改变
- 白日梦增多
- 幻觉出现等。

老师特别纠正的误区

- “有自杀想法的人就是精神病”——错
 - “不能和有自杀念头的人谈自杀”——错，恰恰要适当沟通评估风险
 - “危机缓解就没事了”——错，需要持续干预。
-

六、危机干预怎么做：答题万能框架

1. 总原则

1. 安全第一
2. 保障安全
3. 聚焦当前问题，不是先深挖人格
4. 激活资源
5. 建立关系。

2. 法律伦理问题

保密原则不是绝对的

以下情况要突破保密：

- 明确自杀计划 / 高自杀风险
- 明确要伤害他人
- 涉及违法犯罪
- 未成年人正遭受家庭暴力或其他侵害。

伦理重点

- 信息保密
- 最小披露
- 避免双重关系。

3. 危机干预三个阶段

1. 危机评估：重点评估自杀风险和攻击他人风险
2. 行动干预：高风险时立即通知家长/辅导员、监护、保护起来
3. 心理干预与后续治疗：稳定情绪、解决现实问题、训练应对技巧。

4. 创伤/危机干预三阶段模型

1. 稳定化：先安定、先止血
2. 处理创伤：有节奏地处理，不能粗暴推进
3. 重建意义：重新整合经历。

5. 什么时候开始干预

老师明确说**不是越早越好**。灾难刚发生时先满足食物、水、帐篷、救援等安全生存需要；心理干预一般可在**24~48 小时左右**开始，也可能更晚。

6. 危机干预的基本技巧

- 倾听：言语倾听 + 非言语倾听
- 共情：站在对方位置理解，不等于同情
- 还包括情感反应、具体化、资源利用、稳定化等。

7. 安全措施

- 远离药品、刀具、危险地点
- 必要时监护、送医
- 可签**不伤害协议**。

8. 危机中的典型反应

认知反应

否认、注意力不集中、失去信心、内疚自责，最突出的是**认知变窄**：只看见困难，看不见其他路。

情绪反应

害怕、悲伤、绝望、无助、羞耻、易怒、情绪失调。

行为反应

攻击、退缩、逃避、哭泣、饮酒增加、药物增加、坐立不安、过度警觉。

七、第六讲：学生心理危机三级预防，这里特别像简答题

1. 三级预防定义

1. **一级预防**：消除病因或减少致病因素，防患于未然
2. **二级预防**：三早——早发现、早诊断、早治疗
3. **三级预防**：康复与防复发，减少长期功能损害。

2. 社会层面防自杀共识

- 减少获取自杀手段的机会
- 积极治疗精神障碍患者
- 对自杀未遂者持续随访
- 媒体要负责任报道，防止模仿效应
- 培训基层卫生保健人员。

3. 七类学生高风险对象

1. 有家族史者
2. 有既往史者
3. 单亲家庭学生
4. 经济困难学生
5. 存在人格脆弱者：内向、敏感、脆弱、完美主义等
6. 遭遇应激事件者
7. 已出现精神症状者。

4. 高发时间、年级、场所

- **高发时间**：春夏之交、秋冬之交
- **高发年级**：新生适应期多，但临近毕业年级更重
- **高发场所**：宿舍楼、教学楼等高层建筑，跳楼常见。

5. 学校特色活动

内观认知疗法

- 60 多期，2600 多人参加
- 对 300 多名学生统计，总有效率约 **82.5%**
- 核心作用：感恩、体谅、改变认知方式。

森田疗法

- 创立者：**森田正马**
- 时间：**1919 年**
- 核心：**接纳客观、为所当为、顺其自然**
- 适用于神经症、失眠、适应障碍、应激障碍、抑郁症等。

八、胡鑫宇案例：案例题基本答法

这类案例你不要背时间线，重点背“**分析结构**”。

1. 个人因素

- 内向、孤僻、压抑
- 不适应新环境
- 睡眠障碍
- 高期待与高落差
- 负性认知、自责、自我否定
- 心身症状
- 轻生意念。

2. 家庭因素

- 家长是第一道防线
- 但家长把求助信号当成“娇气”“意志不坚定”
- 经济压力、期待压力、名校光环加剧危机。

3. 学校/教师因素

- 过度关注成绩，忽视心理状态
- 对异常行为识别不足
- 危机识别和转介缺失。

4. 同伴因素

- 同伴未能有效识别、承接、上报。

5. 本人应对因素

- 退避型应对
- 不愿麻烦别人
- 缺乏主动求助。

6. 引出的理论点

- 生命意义教育
- **Karen Horney: 被爱的渴求**
- 缺乏稳定的爱和支持，容易形成不安全感与绝望感。

九、第七讲：最后这节容易考“理解题”

1. 心理问题的客观存在

心理问题看不见、摸不着，但客观存在，不是讲道理就能立刻改变。

2. 内在批评者

有人一道题不会做就崩溃，不只是题难，而是内在有个持续批评自己的声音。老师用这个例子说明心理问题真实存在且能主导行为。

3. 心理问题的三个特点（老师自己的总结）

1. **主观性**：每个人痛苦方式不同
2. **必然性**：不是某件偶然小事“凭空制造”出来的，内在模式会寻找出口
3. **主导性**：越和它缠斗、越对抗，问题可能越厉害。

4. 老师的理解重点

- 痛苦未必主要来自当前外部环境
- 即使换环境，内在模式不变也可能继续痛苦
- 不要过度追求一切可控，要学会接受不确定性。

5. 最后的人生建议类考点

老师还讲到：真正适合的事情，往往是即使没有报酬、没有肯定、暂时没结果，你仍愿意做、做着开心的事。这个更像理解题或开放题。

十、考场上最好用的“万能论述模板”

遇到任何案例题，几乎都可以这么写：

模板一：分析某学生为何出现心理危机

1. **事件诱因**：列出重大应激事件
2. **个体易感因素**：人格、完美主义、冲动性、认知图式、既往史
3. **家庭因素**：支持不足、沟通差、依恋创伤
4. **学校与同伴因素**：识别不足、支持缺失、转介不及时
5. **危机表现**：情绪、认知、躯体、行为
6. **系统视角总结**：这是生物—心理—社会多因素共同作用结果。

模板二：写如何干预

1. **安全第一，先评估风险**
2. **必要时突破保密原则**
3. **行动干预**：通知家长、辅导员、监护、送医、限制危险工具
4. **心理干预**：倾听、共情、稳定情绪、聚焦现实问题
5. **激活资源**：家庭、学校、同伴、社会资源
6. **后续跟踪**：康复、防复发、培养应对技巧。

模板三：写预防

1. **一级预防**：健康教育、课程宣传、减少危险因素
2. **二级预防**：早发现、早诊断、早治疗
3. **三级预防**：康复、防复发

4. 重点人群管理
 5. 高发时段和高发场所防控。
-

十一、最后给你一个“纸质速查索引”

最该带在最前面的只有这 1 页

你真上考场，最值钱的是这几条：

- 心理危机定义
- 三条标准
- 危机类型
- 危机四阶段
- 危机干预定义、两个目的
- 保密例外
- 自杀相关概念
- 自杀先兆
- ASD/PTSD 区别
- 三级预防
- 七类高危人群
- 案例题万能模板。

需要细翻时看哪份笔记

- 定义、标准、危机干预起源与目的 → 第 1 讲
 - 常见原因、生物心理社会模型、成瘾、SAD → 第 2 讲
 - 危机类型、四阶段、ASD/PTSD、自杀概念 → 第 3 讲
 - 依恋、创伤、倾听共情、干预时机 → 第 4 讲
 - 法律伦理、树理论、危机干预三阶段、安全措施 → 第 5 讲
 - 三级预防、高危人群、胡鑫宇、内观、森田 → 第 6 讲
 - 心理问题的客观存在、主观性/必然性/主导性 → 第 7 讲
-

如果你愿意，我下一条直接把这份内容再压成“**两页 A4 可打印版**”，做成更像真正小抄/速查表的格式。